Patientenuntersuchung – Checkliste

xABCDE · SAMPLERS · OPQRST — zum Abhaken im Training und Einsatz-Debriefing

Datum _____ Szenario / Fall _____ Team _____ Beobachter _____

Ersteindruck

- ☐ Eigenschutz, Szene sicher, Anzahl Patienten
- ☐ Ersteindruck: kritisch / nicht kritisch
- ☐ Nachforderung (NA, weitere Kräfte) erwogen

x Exsanguination – kritische Blutung

- ☐ Lebensbedrohliche Blutung gesucht und erkannt
- ☐ Blutung gestoppt (Druck, Druckverband, Tourniquet, Hämostyptikum)
- ☐ Tourniquet-Zeit notiert
- ☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

A Airway – Atemweg (+ HWS)

- ☐ Patient spricht / Atemweg frei
- ☐ Mundraum inspiziert (Fremdkörper, Erbrochenes, Blut, Schwellung)
- ☐ Atemgeräusche (Stridor, Gurgeln, Schnarchen)
- ☐ Atemweg gesichert (Absaugen, Esmarch, Guedel/Wendl, SGA, Intubation)
- ☐ HWS bei Traumamechanismus beachtet / immobilisiert
- ☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

B Breathing – Atmung

- ☐ Atemfrequenz, Atemtiefe, Atemarbeit, Hilfsmuskulatur
- ☐ SpO_2 gemessen
- ☐ Thorax inspiziert (symmetrisch, Prellmarken, paradoxe Atmung)
- ☐ Thorax palpiert (Instabilität, Krepitation, Hautemphysem)
- ☐ Auskultation beidseits, ggf. Perkussion
- ☐ Halsvenen und Trachealage beurteilt
- ☐ $etCO_2$ (falls beatmet / verfügbar)
- ☐ Maßnahmen: O_2, Lagerung, assistierte Beatmung, Entlastung
- ☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

C Circulation – Kreislauf

- [ ] Puls zentral / peripher (Frequenz, Rhythmus, Qualität)
- [ ] Rekapillarisierungszeit
- [ ] Haut: Farbe, Temperatur, Feuchtigkeit
- [ ] Blutdruck gemessen
- [ ] EKG (3-Kanal, 12-Kanal bei Indikation)
- [ ] Blutungsquellen: Thorax, Abdomen, Becken, Oberschenkel, nach außen
- [ ] Abdomen und Becken beurteilt
- [ ] Zugang i.v. / i.o., Volumen, Medikamente

☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

D Disability – Neurologie

- [ ] Bewusstsein: AVPU / GCS
- [ ] Pupillen: Größe, Form, Lichtreaktion, seitengleich
- [ ] Blutzucker gemessen
- [ ] BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time)
- [ ] Motorik und Sensibilität aller Extremitäten
- [ ] Meningismus, Krampfanzeichen, Amnesie

☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

E Exposure / Environment – Untersuchung, Umfeld

- [ ] Entkleidet, Bodycheck von Kopf bis Fuß
- [ ] Rücken untersucht (Log-Roll)
- [ ] Körpertemperatur gemessen
- [ ] Wärmeerhalt sichergestellt
- [ ] Umfeld: Medikamente, Geruch, Hinweise, Unfallmechanismus

☐ Problem erkannt ☐ Maßnahme ergriffen ☐ Reevaluation

SAMPLERS – Anamnese

☐	**S** **Symptome**	Was ist das Hauptproblem? Begleitsymptome?
☐	**A** **Allergien**	Medikamente, Lebensmittel, Pflaster, Latex
☐	**M** **Medikamente**	Dauer- und Bedarfsmedikation, Antikoagulation, Medikamentenplan
☐	**P** **Patientengeschichte**	Vorerkrankungen, OPs, Krankenhausaufenthalte
☐	**L** **Letzte ...**	Mahlzeit, Flüssigkeit, Stuhlgang, Miktion, Menstruation
☐	**E** **Ereignis**	Was ist passiert? Was wurde zuvor getan?
☐	**R** **Risikofaktoren**	Rauchen, Alkohol, Drogen, Diabetes, Hypertonie, Familie
☐	**S** **Schwangerschaft**	Möglich? Welche Woche? Komplikationen?

OPQRST – Schmerz- und Beschwerdeanamnese

☐	**O** **Onset – Beginn**	Plötzlich oder langsam? Wobei aufgetreten?
☐	**P** **Provocation / Palliation**	Was verstärkt, was lindert? Lage, Bewegung, Atmung
☐	**Q** **Quality – Qualität**	Drückend, stechend, brennend, ziehend, kolikartig
☐	**R** **Region / Radiation**	Wo genau? Strahlt es aus?
☐	**S** **Severity – Stärke**	NRS 0–10: ____
☐	**T** **Time – Zeit**	Seit wann? Dauerhaft oder intermittierend? Schon einmal gehabt?

Abschluss

- ☐ Verdachtsdiagnose formuliert
- ☐ Transportziel und -priorität festgelegt
- ☐ Übergabe strukturiert (z. B. SINNHAFT / SBAR)
- ☐ Dokumentation vollständig

Notizen / Debriefing

Allgemeine Lernhilfe, ersetzt keine lokalen SOPs oder Algorithmen.